

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91
E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Закладам охорони здоров'я
(за списком)

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) висловлює свою повагу та надає роз'яснення щодо правил ведення електронних медичних записів (далі – ЕМЗ) в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) для потенційних донорів, яким встановлено смерть мозку.

У 2019 році за ініціативи Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховна Рада України ухвалила законодавчу базу, яка дала старт розвитку трансплантації в Україні. Ці законодавчі зміни, насамперед, були спрямовані на зменшення кількості пацієнтів, які вимушені були їхати на пересадку органів за кордон, та наближення цієї життєво необхідної допомоги до пацієнта.

Після початку реформи трансплантології та попри війну ця галузь медицини в Україні продовжує розвиватися. Пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я України (далі – МОЗ) із трансплантації, що тривав три роки, завершився і відповідно до пункту 4 Розділу IV Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 січня 2024 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення щодо забезпечення організації медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або провадження діяльності, пов'язаної з трансплантацією здійснюється за програмою медичних гарантій (далі – ПМГ).

У 2024 році в рамках ПМГ для забезпечення таких потреб було впроваджено пакет медичних послуг «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів».

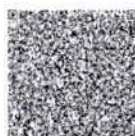
Однак, не зважаючи на те, що трансплантація органів врятувала сотні життів пацієнтів із термінальною органною недостатністю, більше 20% пацієнтів у списках очікування щороку помирають через відсутність донорських органів.

Тому, отримання органів від померлого донора – пацієнта із встановленою смертю мозку є важливим кроком для процесу трансплантації.

Правила внесення інформації в ЕСОЗ про надані медичні послуги пацієнту- мертвому донору

Відповідно до статті 52 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» моментом незворотної смерті людини є момент смерті її головного мозку або її біологічна смерть.

Порядок припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта, порядок констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини, положення



про консилиум лікарів, форма акту про констатацію смерті мозку людини визначено наказом міністерства охорони здоров'я України «Про деякі питання удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії закладів охорони здоров'я» від 09.11.2020 № 2559.

Відповідно до пункту 3 «Порядку припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта» активні заходи щодо підтримання життєдіяльності пацієнта припиняються у випадку підтвердження незворотної смерті - констатації смерті мозку пацієнта консилиумом лікарів, за винятком випадків, коли померла людина розглядається як потенційний донор.

Відповідно до статті 1 розділу I Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»: потенційний донор - померла особа, щодо якої існують медичні передумови (відсутність хвороб або станів, що унеможливають вилучення анатомічних матеріалів людини) для вилучення анатомічних матеріалів, але не отримано трансплант-координатором в установленому цим законом порядку відомості щодо можливості (згода) вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

Відповідно до Порядку констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини, затвердженого наказом міністерства охорони здоров'я України від 09.11.2020 № 2559 «Про деякі питання удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії закладів охорони здоров'я», в разі констатації смерті мозку потенційному донору до моменту вилучення органів проводиться кондиціонування - сукупність дій медичного характеру, спрямованих на забезпечення підтримання функцій життєво важливих органів та систем потенційного донора.

Відповідно до пункту 5 розділу I «Складу та основних завдань бригади вилучення анатомічних матеріалів людини», затвердженого наказом МОЗ від 11.06.2021 № 1184 «Деякі питання організації посмертного донорства»: після констатації смерті мозку продовжується кондиціонування потенційного донора, про що вноситься відповідний запис у формі первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

Записи щодо лікарських засобів використаних під час кондиціонування потенційного донора вносяться до форми первинної облікової документації № 003-4/о «Листок лікарських призначень», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Відповідно до статті 1 розділу I Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»: донор-труп – померла особа, щодо якої в установленому цим законом порядку отримано згоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

Відповідно до пункту 7 розділу III «Складу та основних завдань бригади вилучення анатомічних матеріалів людини»: вилучення у донора-трупа анатомічних матеріалів для трансплантації документується шляхом заповнення форми № 033/о «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2021 року № 1184 (далі - форма № 033/о).

Форма № 033/о підписується лікарями, які брали участь у вилученні анатомічних матеріалів для трансплантації, а у разі призначення судово-медичної експертизи - також судово-медичним експертом, і долучається до висновку судово-медичного експерта, медичної документації донора-трупа та реципієнта.

Враховуючи зазначене, ЕМЗ для пацієнта, якому встановлено діагноз смерть мозку і визнано донором-трупом, має містити наступну інформацію:

1. *Підстава надання послуги* – вибрати одне з:
 - За електронним направленням;
 - Самозвернення;
 - Бригадою екстреної медичної допомоги;
 - Переведений з іншого ЗОЗ;
 - Переведений з іншого відділення;
 - Доставлений третіми особами.
 - Пошук е-направлення в ЕСОЗ виконується за груповим номером направлення.
 2. *Епізод*. Тип епізоду «Лікування», де дата початку епізоду зазначається як дата госпіталізації в стаціонар.
 3. *ЕМЗ «Взаємодія»*:
 - *Клас взаємодії* – «Стаціонарна медична допомога»;
 - *Тип взаємодії* – «Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару»;
 - *Результат лікування* – «Смерть пацієнта»
 4. *Основний діагноз* – зазначити діагноз, який встановлено після обстеження і який є основною причиною виникнення епізоду лікування пацієнта та на який спрямовано основні медичні інтервенції.
 5. *Клінічний статус основного діагнозу* – завершений.
 6. *Статус достовірності діагнозу* – «Заключний».
 7. *Додатковий діагноз* – **обов'язково зазначаються**:
 - **G93.82** Смерть головного мозку;
- У разі вилучення органів, відповідно до «Акту про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації» зазначаються діагнози розділу **Z52** Донори органів та тканин.
- Якщо після кондиціонування органи не вилучають для проведення трансплантації, зазначають діагнози **Z00.5** Обстеження потенційного донора органу й тканини та **Z53.8** Процедура не проведена з інших причин.
- Також зазначаються діагнози, що мають відношення до даного клінічного випадку.

8. *Проведені дії* – опис проведених дій відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій», зазначаються коди процедур, які були проведені під час лікування, окрім інтервенцій, які були проведені під час кондиціонування, за виключенням операцій з вилучення анатомічних матеріалів:

- 90204-00 Видалення серця донора для пересадки;
- 90204-01 Видалення серця та легені донора для пересадки;
- 38438-03 Видалення легені донора для пересадки;
- 96258-03 Забір трансплантату печінки від трупа;
- 36516-06 Повна нефректомія задля трансплантації, трупний донор.

9. *Закриття епізоду* – епізод має бути закритим, електронне направлення на даний вид лікування погашене. Дата закриття епізоду – час закінчення вилучення органів відповідно до «Акту про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації» або дата встановлення непридатності до донорства потенційного донора.

Голова

Наталія ГУСАК



ЗІСНОВО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст відділу контролю,
документального забезпечення
та архіву
Оксана Сибирська
04.04.2024